

NS 227310020

AROLDIO DIAS

IDADE: 68 anos PESO: 92 ALTURA: 1,65 PROFISSÃO: Contador
 SINTOMAS: Ronco; cansaço diurno, sono não reparado.
 QUEIXAS: sono leve diurna.
 MEDICAMENTOS:

MÉDICO: Dra. Fabíola Opina

EXERCÍCIO FÍSICO:

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 23-24 HORA QUE ACORDA: 5h

COCHILHO () SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM (X) NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: oral. BANHEIRO: 3x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: MALLAMPATI: IV IAH: 58,2 e/h SPO2: 75%.

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Desvio septo pl. Exg.

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS

PSG cl. titulação: CPAP: 5 cmH₂O (IAH = 22 e/h).18/12/2023 Adaptação 5 a 15 cmH₂O máx. vent. (L)

21/12 P = 9 cmH₂O
 23 IAH = 0,7 e/h
 M. de uso: 4h40'

fua

18/01/24 P = 9,0 cmH₂O acordar as 5hr. ↑ P = 10

24/01 P = 10 cmH₂O
 24 IAH = 2,4 e/h
 m. de uso: 7h30'
 Fuga = 11,3 e/min

Bem adapt.

fua

21/02 P = 10 cmH₂O
 24 IAH = 3,2 e/h
 m. de uso: 6hr.
 Bem adapt.

fua

30/04 P = 10 cmH₂O
 24 IAH = 2,7 e/h
 m. de uso: 6h17'

Relata melhora do sono.
 sem queixas. fua

03/04/25 P=7,2 cm H₂O (5-16 cm H₂O)

TAH = 3,5 e 1h

um de ura: 5h 14l

freq: 10,2 e 1m

sem adaptado

* troco filtro

* Oriente sobre contância

no horário de dormir

* ajuste P = 5-10,5 cm H₂O

Natacha

Nome: AROLDI DIAS

Data de Nascimento: 1-6-1955

IMC: 34,58

Sexo: Masculino

Data do exame: 24-10-2023

Peso: 93 kg

Altura: 1,64 m

Médico: DRA. PÁTRICIA DANIELA OYAMA

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia para titulação de CPAP

Exame realizado na noite de 24-10-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 495,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 32,0 e 54,0 minutos. O tempo total de sono foi de 406,5 min, eficiência de 82,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,3%; estágio N2: 52,5%; estágio N3: 22,8%; sono REM: 22,4%. O índice de despertares foi de 11,0/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 22,1/hora, sendo 2 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 148 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 80%, permanecendo 1,5% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 52 - 81 bpm e NREM de 53 - 76 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (14), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
4. aumento do número de despertares breves;
5. registro de ronco durante o sono.

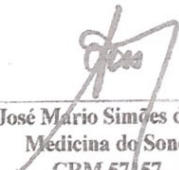
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 5,0 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157